جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : بدور احمد على عبدالجليل

المحافظة : القاهره
الحي / المدينة : الخليفه
العنوان : 9 ش عامر - الخرطه القديمه - السيده عائشه

رقم البطاقة : 29004070104622
رقم التليفون : 01145746802
تاريخ تسجيل الإستمارة : 20-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 07-04-1990 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع:(--------------------------**)**

المقر بما فيه
التوقيع:(--------------------------**)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** --------------------------- **التوقيع:** نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --
خطة العلاج : --
المستشفي : -- **قسم :** --
جهة العلاج : -- **نفقات :** --
ملاحظات : --

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

مدير عام
مديرية الشئون الصحية

ختم
شعار الجمهورية

Name: بدور احمد على عبدالجليل
National ID: 29004070104622

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

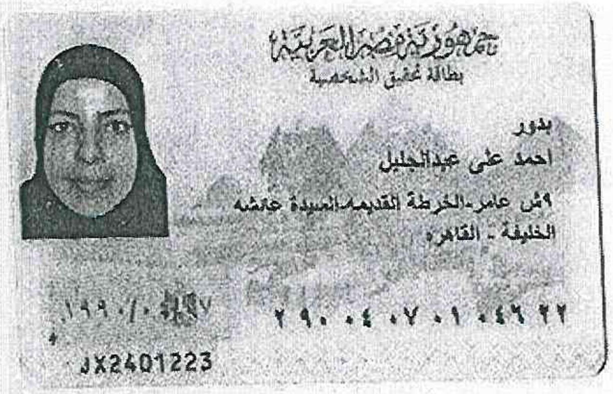
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

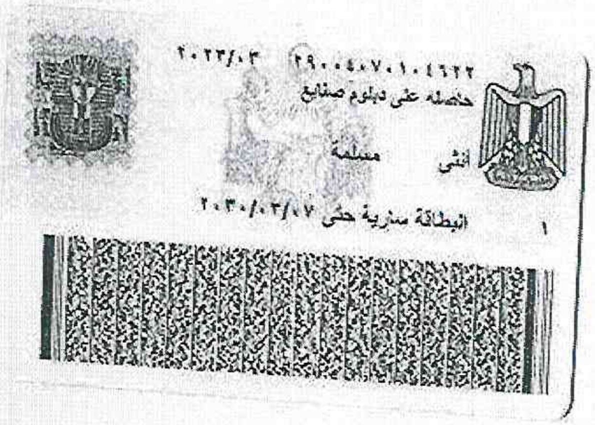
بدور
احمد على عبدالجليل
٩ش عامر-الخرطة القديمه-السيدة عائشه
الخليفة - القاهره

١٩٩٠/٠٤/٠٧
٢٩٠٠٤٠٧٠١٠٤٦٢٢
JX2401223

٠١١٤٥٧٤٦٨٠٢
٠١٢٢٠٣٢٦٩٦٠

DMS
تدعيم ←
صاموبيل ←
مطعمية ←

٠١١٤٥٧٤٦٨٠٢



٢٩٠٠٤٠٧٠١٠٤٦٢٢ ٢٠٢٣/٠٣
حاصله على دبلوم صنايع
انثى مسلمة
١ البطاقة سارية حتى ٢٠٣٠/٠٣/٠٧

National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	بدور احمد على عبد الجليل 0	**Code Number**	YK 262274
Sex/Age	Female 36 Y	**Patient ID**	19967
Registered Date	19/5/2026 03:58:08 PM	**Referred By Dr.**	Interventional Radiology
Validation Date	08/6/2026 08:58:54 PM	**Branch**	Gustave Roussy
Reporting Date	10/6/2026 10:26:17 AM	**Pathology No.**	1589/26

Clinical Data: Left breast mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 19/05/2026, at 1:30 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.
Gross Examination: Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
- **Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
- **Histologic grade:** 3 (differentiation 3, pleomorphism 3, mitosis 3)
- **DCIS:** Absent.
- **Microcalcification:** Absent.
- **Angioinvasion:** Absent.
- **Perineural invasion:** Absent
- **Necrosis:** Widely necrotized.
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Weak nuclear reaction in <1% of tumor cells (score 2/8).
- PR: Negative nuclear reaction in tumor cells (score 0/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 98%.

Conclusion:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 3.
IPT:
- ER: Negative (score 2/8).
- PR: Negative (score 0/8).

Breast Biopsy
[[DOCTYPE:BREAST_BIOPSY]]

Name: بدور احمد على عبدالجليل
MR. : 11471

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من
بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:
رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :
تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 36-year-old pre-menopausal individual with a positive family history of breast cancer in the mother and sister. No co-morbidities are reported. The clinical history notes that contrast-enhanced spectral mammography (CESM) films have been provided.

Core needle biopsy demonstrated invasive ductal carcinoma, grade 3. Immunohistochemistry showed estrogen receptor 2/8, progesterone receptor 0/8, HER2 negative (0), and a Ki-67 proliferation index of 98%. Imaging revealed a left-sided unifocal lesion measuring 6 × 3.6 × 2 cm, located 11 cm from the nipple, with more than three pathological lymph nodes identified on sonomammography. Staging workup with CT of the chest, abdomen, and pelvis and a bone scan were both negative for metastatic disease.

The referring team recommended clipping of the tumor, BRCA genetic testing, neoadjuvant chemotherapy (NACT), followed by left-sided wide local excision (WLE) and axillary lymph node dissection (ALND). The multidisciplinary team concurred with clipping and BRCA testing, and added placement of a portacath. The agreed NACT regimen consists of 12 weeks of paclitaxel plus carboplatin combined with pembrolizumab (Ketruda), followed by four cycles of doxorubicin-cyclophosphamide (AC) with pembrolizumab. After completion of systemic therapy, the plan is to proceed with left-sided WLE and ALND.

تحريرا في ,

التاريخ : 23-09-2026
الوقت :

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

Patient Name	بدور احمد على عبد الجليل 0	**Code Number**	YK 262274
Sex/Age	Female 36 Y	**Patient ID**	19967
Registered Date	19/5/2026 03:58:08 PM	**Referred By Dr.**	Interventional Radiology
Validation Date	08/6/2026 08:58:54 PM	**Branch**	Gustave Roussy
Reporting Date	10/6/2026 10:26:17 AM	**Pathology No.**	1589/26

- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 98%.

***Scoring system: "ER, PR"*

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

*** Scoring system: "Her2"*

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim

٢٩٠٠٤٠٧٠١٠٤٩٢٢

إسم المريض ثلاثي: ....
رقم الملف: ....

تقريـــر طبـــى

السيد/..

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من .... بشان تقرير طبي للمريض: بدور احمد

بقسم.......................رقم طبي ....

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول........................تاريخ وساعة الخروج..................................

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

36 yrs old Breast Ca

on NACT, one offspring C.1 child)

for Zoladex

تحريرا في

الوقت: .... **التاريخ :** / /

الطبيب المعالج

....

يعتمد ،،